

AX01-POE Seguimiento INR-001-v3: PAUTA DE AJUSTE PARA PACIENTES CON INR FUERA DE RANGO

Manejo de INR fuera de rango 2-3 TAO con acenocumarol (Sintrom®) y warfarina (Aldocumar®)	
Situación clínica	Pauta
INR < 1.4	Aumento de dosis de 10-20% (aproximadamente 1-2 mg/semana) y HBPM (dosis terapéuticas) si riesgo elevado de trombosis, durante 3 días, hasta INR en rango. Control a la semana
INR 1.4-1.6	Aumento de dosis 5-10% (aproximadamente 1 mg/semana). Control a la semana
INR 1.7-2 INR 3-3.4	Mantener dosis. Considerar en rango o adelantar siguiente control.
INR 3.5-4.9	Reducir dosis semanal en 10-20% (aproximadamente 1-2 mg) omitiendo la dosis de ese día. Control a la semana
INR ≥ 5**	Interrumpir TAO y administrar 2 mg de vit K (Konakion®) si alto riesgo de sangrado o INR > 8. Control al tercer día. Reanudar TAO reduciendo DTS última 1-2 mg y control a la semana.

*Si los valores INR ≥ 5 se repiten en varias ocasiones (a partir de 3 determinaciones consecutivas), se podrá contactar con Hematología (vía telefónica) para valorar derivación

✧: Los enfermeros acreditados sólo podrán actuar hasta INR ≤ 5. En caso de pacientes con INR ≥ 5 tendrán que informar al MAP para que sea éste el que lo valore.

Manejo de INR fuera de rango 2.5-3.5 (prótesis metálicas) TAO con acenocumarol (Sintrom®) y warfarina (Aldocumar®)	
INR < 1.8	Aumento de dosis 10-20% (aproximadamente 1-2 mg/semana) y HBPM si riesgo elevado de trombosis, durante 3 días, hasta INR en rango. Control a la semana
INR 1.9-2.3	Aumento de dosis 10-20% (aproximadamente 1-2 mg/semana). Control a la semana
INR 2.4-2.5 INR 3.5-3.8	Sin cambios en la dosis. Adelantar siguiente control.
INR 3.9-4.9	Reducir dosis semanal en 10-20% (aproximadamente 1-2 mg) omitiendo la dosis de ese día si INR próximo a 5 y riesgo de hemorragia. Control a la semana.
INR ≥ 5	Interrumpir TAO. Control al 3º día. Si sangrado o riesgo aumentado de hemorragia, administrar 2 mg de vit K (Konakion®). Reanudar TAO cuando INR < 5 reduciendo DTS última 1 mg. Interrumpir TAO. No administrar Vitamina K y vigilar datos de sangrado por si procede derivar al servicio de Urgencias. Control al tercer día. Reanudar TAO reduciendo DTS última 1 2 mg y control a la semana.